PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Exercício na doença crônica

Prescrição segura e o custo do afastamento

Medicina Esportiva Clínica

CASO ILUSTRATIVO

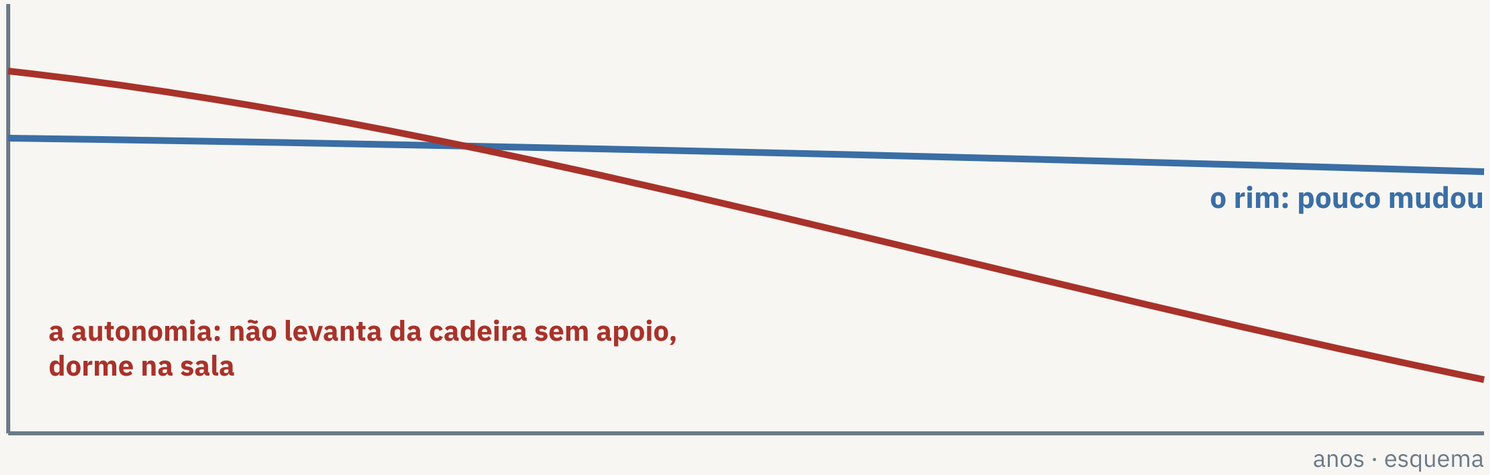
Ouviu que não podia fazer esforço. E obedeceu.

casa dos sessenta

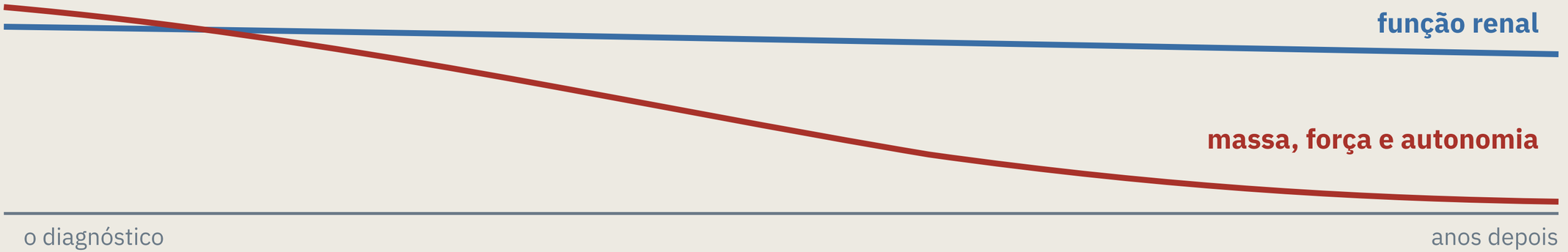
doença renal crônica moderada, diabetes, hipertensão

“Com rim doente, não pode fazer esforço.”

e ele obedeceu



A frase protegeu o rim de um risco que não estava ali



Na doença renal crônica, a principal causa de morte é cardiovascular. A diretriz de 2024 recomenda atividade moderada, 150 minutos por semana ou o tolerado.

Esquema, sem valores medidos · KDIGO 2024, recomendação 3.2.2.1

A MESMA INVERSÃO EM QUASE TODA DOENÇA CRÔNICA

Não é se pode treinar, é como

Doença renal crônica

atividade moderada, 150 min por semana ou o tolerado

Diabetes tipo 2

exercício é tratamento: glicemia, insulina, risco cardiovascular

Hipertensão

reduz a pressão; entre as primeiras condutas

Asma

melhora o condicionamento, bem tolerado

Câncer

exercício durante e depois do tratamento

Cardiopatia estável

exercício supervisionado faz parte do tratamento

> Autonomia não é desfecho secundário: levantar da cadeira, subir escada, dormir no próprio quarto.

O QUE ORGANIZA QUALQUER CASO

Três perguntas antes da prescrição

1

Existe instabilidade clínica agora?

onde moram as contraindicações reais, quase todas temporárias

→

2

Que medicações usa, e o que fazem no esforço?

a pergunta que mais muda a prescrição

→

3

O que consegue fazer hoje?

não o que a diretriz recomenda: o que ela consegue

→

a prescrição

AS CONTRAINDICAÇÕES DE VERDADE

Quase tudo é “agora”, não “para sempre”

Coronária instável

síndrome aguda recente, angina instável

Coração descompensado

insuficiência cardíaca, arritmia não controlada

Pressão muito alta

e não controlada

Sintoma novo no esforço

que ninguém avaliou

Febre

infecção aguda

Metabólico

cetose, hipoglicemia grave recente

Lesão em investigação

A conduta

“hoje não, por isso; vamos resolver e começar”

> O erro simétrico ao afastamento é a prescrição impossível: fracasso, culpa e abandono.

Remédios que mudam a prescrição

Betabloqueador

sem alvo de FC por fórmula; percepção de esforço, fala, teste com o remédio

Insulina, sulfonilureia

glicemia antes, carboidrato à mão, hipoglicemia tardia

Inibidor de SGLT2

hidratação e calor; cetoacidose rara com glicemia pouco alta

Diurético

volume, eletrólitos, cãibra

Anti-hipertensivos

tontura ao terminar: desaquecer

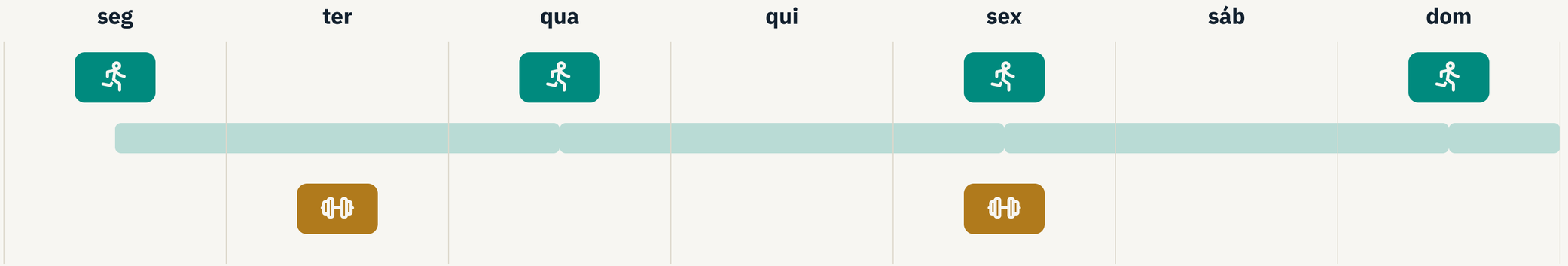
Estatina, anticoagulante

ouvir a dor muscular; contato e queda

> Quem prescreve treino precisa saber o que a pessoa toma, e quem prescreve remédio precisa saber que ela treina.

DIABETES TIPO 2, O MAIS FREQUENTE

O benefício tem prazo de validade



faixa clara: 24 a 72 h de sensibilidade à insulina depois de cada sessão aeróbica

nunca mais de 2 dias seguidos sem aeróbio · força em 2 dias: o músculo é o principal destino da glicose · esquema

Cuidados: hipoglicemia com insulina e sulfonilureia, inspeção dos pés, neuropatia autonômica, retinopatia. Glicemia alta com cetose: dia de resolver o controle.

Associação Americana de Diabetes, Diabetes Care 2016

AS OUTRAS CONDIÇÕES

Ajustar, não parar

Hipertensão

aeróbio com força; pressão descontrolada adia a sessão; desaquecer

Cardiopatia estável

a prescrição sai de um teste, compartilhada com a cardiologia

Câncer

≈ 30 min, 3 vezes por semana, força ao menos 2; fadiga, humor, função

Doença renal

força no centro; proteína, sódio, potássio e fósforo com nutrição e nefrologia

> Ninguém aumenta proteína por conta própria em quem tem doença renal, e isso inclui suplemento da loja.

Mesa-redonda internacional de exercício no câncer, Med Sci Sports Exerc 2019

O CASO, CONDUZIDO PELO QUE A AULA CONSTRUIU

A meta não está no laudo

1

Avaliar

estabilidade, seis remédios revisados, função; teste de esforço com a medicação

2

Começar pelo possível

levantar da cadeira com apoio, caminhadas curtas em casa

3

Progredir

força duas vezes por semana; intensidade pela percepção, não pela FC

4

Combinar a equipe

nutrição, nefrologia, endocrinologia; tontura ao terminar volta ao médico



A meta

voltar a subir a escada e dormir no próprio quarto

AS REGRAS QUE O CASO ENTREGA

Afastar é uma intervenção

Afastar tem efeito adverso

e pede reavaliação

Como, não se

contraindicações específicas e temporárias

A medicação muda a prescrição

Comece pelo que consegue

a prescrição impossível também faz mal

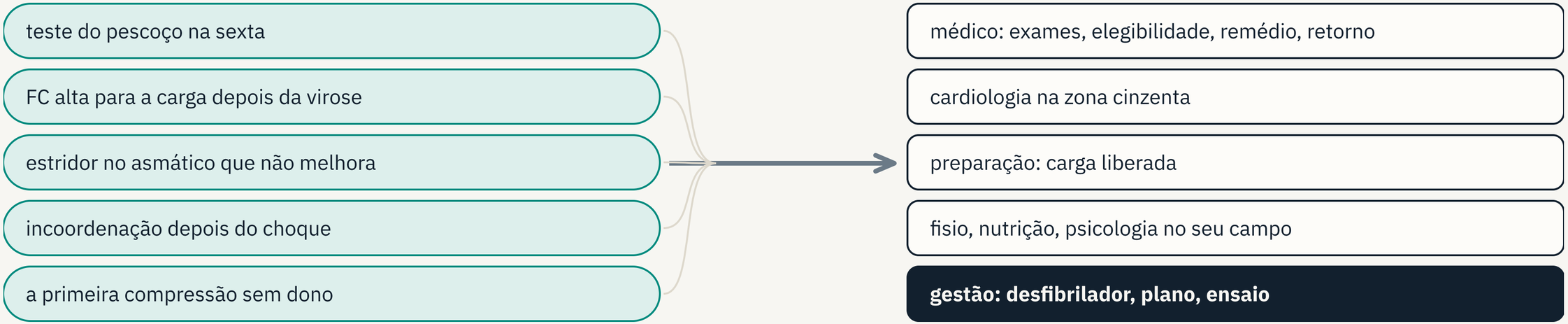
Força não é opcional

é o que preserva autonomia

O desfecho nem sempre é o exame

às vezes é a escada

Decisão e contribuição



> A decisão administrativa que mais muda desfecho no módulo é da gestão.

RECONHECIMENTO: DE TODOS

Exame, remédio e afastamento são intervenções

- ✓ Síncope no esforço, morte súbita na família, “hipertrofia” no laudo
- ✓ Caiu sem contato e não responde; tosse que todo mundo tem; febre na véspera
- ✓ Gelo na boca, check-up completo, comprimido no vestiário, “não pode fazer esforço”

Decisão

Cada profissão decide no seu campo, com registro.

Contribuição

A informação que atravessa profissões.

Reconhecimento

Não exige a profissão certa. Exige ter aprendido o sinal.

Todas pedem uma pergunta clínica antes. Próximo módulo: lesões, mecanismos, epidemiologia e prevenção.